

PROCESSUS DE SOINS PHARMACEUTIQUES

Cours maître remédié et enrichi à partir du document ACTeRX fourni, du plan directeur PEBC 2026 et des normes canadiennes de pratique

Objectif : apprendre à raisonner comme pharmacien : recueillir les bonnes données, identifier et prioriser les problèmes pharmacothérapeutiques, bâtir un plan avec le patient, le mettre en œuvre, documenter et assurer le suivi.

Réflexe universel : COLLECTE → ÉVALUATION → PLAN → MISE EN ŒUVRE → SUIVI/ÉVALUATION → nouvelle collecte.

Important : le document source comporte 25 pages principalement sous forme de diapositives/images. Il constitue une excellente charpente, mais il est trop condensé pour un apprentissage approfondi et ne comporte que 6 QCM. Le présent cours développe la logique clinique et l'entraînement PEBC sans remplacer les exigences provinciales applicables.

1. Pourquoi un processus de soins normalisé

Le sens du processus

Un processus commun rend les soins reproductibles, traçables et centrés sur le patient. Le pharmacien ne “valide” pas seulement une ordonnance : il vérifie que chaque médicament est **indiqué, efficace, sécuritaire et utilisable/observé**, puis il mesure les résultats.

Lien PEBC 2026

Le blueprint PEBC 2026 place la **Clinical Care à 50 % de la Partie I**. Les compétences comprennent obtenir l'information pertinente, évaluer les besoins et préférences, élaborer le plan, le mettre en œuvre et surveiller/réviser les soins.

Modèle mental

Pensez à une boucle de contrôle : on mesure l'état du patient, on compare à une cible, on agit, puis on remeure. Sans suivi, le processus est incomplet.

2. Étape 1 — COLLECTE : construire l'histoire utile

Données patient

Identité, âge, poids/taille si pertinents, grossesse/allaitement, allergies et nature de la réaction, habitudes de vie, tabac/alcool/substances, objectifs, valeurs, préférences, capacité de gérer les médicaments, littératie, accès financier et social.

Données maladie

Diagnostics, symptômes, durée, gravité, évolution, antécédents, examens, signes vitaux, résultats de laboratoire, hospitalisations, événements récents et red flags.

Données médicaments

Prescription, OTC, produits naturels, vitamines, médicaments PRN, vaccins, traitements arrêtés récemment. Pour chacun : indication, dose, voie, fréquence, durée, efficacité perçue, effets indésirables, adhésion, technique d'administration.

La question qui change tout

“**Comment prenez-vous réellement vos médicaments?**” est souvent plus informative que “Prenez-vous vos médicaments comme prescrit?”. Une discordance ordonnance-réalité peut expliquer échec, toxicité ou interaction.

Données manquantes

Une valeur de laboratoire absente peut être elle-même un problème. Exemple : ACEi/ARA + aucune créatinine/K+ récente = sécurité non démontrée; ne pas inventer une conclusion.

3. Étape 2 — ÉVALUATION : les 5 questions

Question 1 — Indication

Chaque médicament a-t-il une indication actuelle et valide? Existe-t-il une indication non traitée? Un médicament sans indication expose à des risques sans bénéfice.

Question 2 — Efficacité

Le médicament convient-il à la condition? La dose/voie/fréquence permettent-elles d'atteindre la cible? La cible clinique est-elle atteinte?

Question 3 — Innocuité

Le patient peut-il subir un effet indésirable, une interaction, une contre-indication, une dose excessive ou une accumulation rénale/hépatique?

Question 4 — Observance / utilisation

Le patient peut-il et veut-il prendre le traitement comme prévu? Rechercher coût, compréhension, complexité, oubli, croyances, effets indésirables, difficultés physiques et technique.

Question 5 — Besoin non traité

Existe-t-il une maladie/risque nécessitant prévention ou traitement? Cette question évite de regarder seulement les médicaments déjà présents.

4. Les catégories de problèmes pharmacothérapeutiques

Indication

1) médicament sans indication valide; 2) besoin d'un traitement additionnel.

Efficacité

3) médicament inefficace/inapproprié pour la condition; 4) dose trop faible ou exposition insuffisante.

Innocuité

5) effet indésirable/interactions/contre-indication; 6) dose trop élevée ou exposition excessive.

Utilisation/observance

7) le patient ne reçoit pas réellement le traitement attendu : oubli, coût, technique, compréhension, choix du patient, accès.

Formuler le problème

Évitez "HTA". Préférez : "**PA non contrôlée malgré ramipril 10 mg/j; adhésion à confirmer; cible à individualiser.**" Le problème doit contenir assez d'information pour guider l'action.

5. Prioriser : urgence, gravité, bénéfice net

Ordre pratique

1) menace immédiate/vitale; 2) toxicité grave ou risque imminent; 3) maladie non contrôlée à fort impact; 4) prévention; 5) optimisation/confort.

Priorité ≠ anomalie la plus impressionnante

Une HbA1c élevée peut être importante, mais un INR très supratherapeutique avec saignement potentiel peut exiger une action plus urgente. Le contexte clinique décide.

Réflexe PEBC

Quand la question demande "**en premier**", cherchez l'urgence, la donnée critique manquante, le médicament causal ou l'action qui protège immédiatement le patient.

6. Étape 3 — PLAN DE SOINS

Objectifs

Définir des objectifs **mesurables, pertinents et temporels** : symptôme, valeur physiologique, fonction, prévention d'un événement, qualité de vie.

Interventions

Pharmacologiques et non pharmacologiques. Pour chaque option : bénéfice attendu, délai d'effet, risques, interactions, faisabilité, préférences et coût.

Décision partagée

Le meilleur plan pharmacologique n'est pas un bon plan si le patient ne peut pas ou ne veut pas le suivre. Expliquer les options, vérifier les priorités du patient, décider ensemble.

Plan de surveillance

Toujours définir : **quoi** mesurer, **quand**, **par qui**, quelle cible, quel seuil d'alerte et quelle action si la cible n'est pas atteinte.

7. Étape 4 — MISE EN ŒUVRE

Transformer le plan en action

Enseignement, adaptation/renouvellement/prescription si autorisés, communication avec prescripteur, orientation, administration, synchronisation, outils d'adhésion, commande de laboratoire selon champ de pratique.

Teach-back

Ne demandez pas seulement "Avez-vous compris?". Demandez : **"Pour être sûr que je me suis bien expliqué, pouvez-vous me montrer/comment me dire comment vous allez le prendre?"**

Sécurité

Donner les red flags et quoi faire. Exemple : anticoagulant → saignement majeur, chute avec traumatisme crânien, selles noires; expliquer quand appeler/consulter en urgence.

8. Étape 5 — SUIVI ET ÉVALUATION

Deux axes

Efficacité : la cible s'améliore-t-elle? **Innocuité** : y a-t-il toxicité? Ajouter adhésion, expérience patient et faisabilité.

Statut

Résolu, amélioré, stable/contrôlé, partiellement amélioré, inchangé, aggravé ou nouveau problème. Chaque statut conduit à une décision : poursuivre, ajuster, arrêter, investiguer ou référer.

Boucle

Le suivi n'est pas la fin : il produit une nouvelle collecte. Le processus est cyclique.

9. Communication centrée sur le patient

Écoute active

Réduire les distractions, reformuler, valider les préoccupations, laisser des silences utiles, observer les indices non verbaux.

Questions ouvertes puis ciblées

Commencer large : "Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus?" puis préciser par questions fermées quand nécessaire.

Entretien motivationnel

Explorer l'ambivalence sans confrontation. Faire émerger les raisons du patient pour changer. L'objectif n'est pas de "gagner" une discussion mais de soutenir une décision éclairée.

Littératie en santé

Utiliser langage simple, une idée à la fois, démonstration, pictogrammes si utile et teach-back. Une faible littératie ne doit jamais être assimilée à un manque d'intelligence.

10. Entrevue médicamenteuse et counseling

Histoire médicamenteuse complète

Inclure prescription, OTC, produits naturels, allergies/réactions, traitements arrêtés, vaccins, habitudes réelles et sources multiples si possible.

Nouvelle ordonnance

Expliquer indication, bénéfice attendu, comment prendre/utiliser, effets indésirables fréquents et graves pertinents, interactions majeures, oubli de dose, conservation, durée et suivi.

Renouvellement

Ne pas répéter automatiquement tout le counseling : vérifier ce qui a changé, efficacité, effets indésirables, adhésion, technique, nouvelles maladies/médicaments et besoin de suivi.

Autosoins

Utiliser une démarche structurée type QuEST/SCHOLAR : symptômes, caractéristiques, histoire, médicaments, allergies, conditions médicales, exclusions/red flags, stratégie, information et suivi.

11. Documentation et note SOAP

Pourquoi documenter

Continuité, communication, responsabilité professionnelle, sécurité et preuve du raisonnement. Documenter les faits pertinents, l'évaluation, le plan et le suivi.

S — Subjectif

Motif, histoire et symptômes rapportés, expérience du patient, préférences, adhésion déclarée.

O — Objectif

Signes vitaux, laboratoire, mesures, médicaments vérifiés, observations et données vérifiables.

A — Analyse

Problèmes pharmacothérapeutiques identifiés et priorisés; lien entre données et conclusion.

P — Plan

Interventions, objectifs, surveillance, enseignement, communications/références et date de suivi.

Piège

SOAP n'est pas un copier-coller de tout le dossier. Une note utile est concise mais suffisamment précise pour qu'un autre professionnel comprenne **ce qui se passe, pourquoi, ce qui a été décidé et ce qui doit être surveillé**.

12. Collaboration et transitions de soins

Communication interprofessionnelle

Partager une recommandation structurée : problème → données pertinentes → évaluation → recommandation → monitoring.
Fermer la boucle : qui fera quoi et quand?

Transitions

Admission, congé, changement de prescripteur ou milieu = risque de divergence. Faire conciliation médicamenteuse, identifier arrêts/ajouts/doses, documenter le motif et transmettre le plan.

Cadre juridique

Les normes NAPRA donnent un cadre national; le champ de pratique et les obligations précises varient selon la province/territoire. Pour l'exercice réel, appliquer les règles du régulateur local.

13. Cas clinique maître — du dossier brut au plan de soins

Patiente : 71 ans, essoufflement à l'effort, oedèmes des pieds. Antécédents : insuffisance cardiaque légère, infarctus il y a 4 ans, fibrillation auriculaire, diabète de type 2, hypertension. Médicaments : metformine 500 mg BID, oméprazole 20 mg DIE, digoxine 0,125 mg DIE, warfarine 5 mg DIE, AAS 81 mg DIE, furosémide 40 mg DIE, métoprolol XL 100 mg DIE. Allergie : pénicilline. Examen : TA 169/88, FC 62, oedèmes, crépitants aux bases. Laboratoire : INR 3,5, glycémie à jeun 11,0 mmol/L, HbA1c 9,5 %, créatinine 115 µmol/L, DFG_e ~43 mL/min/1,73 m².

Collecte : que manque-t-il?

Durée/aggravation de la dyspnée, orthopnée/PND, poids récent, douleur thoracique, observance, sel/liquides, dose réellement prise, indication actuelle de l'AAS avec warfarine, saignements, valeurs antérieures INR, potassium, fonction rénale antérieure, signes de congestion, plan d'insuffisance cardiaque, médicaments OTC/AINS.

Évaluation et priorités

1. Congestion/possible décompensation cardiaque : symptômes + oedèmes + crépitants → priorité clinique. **2.** INR 3,5 : supratherapeutique selon cible habituelle de FA, avec risque hémorragique; vérifier saignement et causes. **3.** Diabète non contrôlé : HbA1c 9,5 %, glycémie 11. **4.** TA 169/88 : contrôle insuffisant. **5.** Double exposition warfarine + AAS : vérifier indication et durée, car risque de saignement. **6.** Fonction rénale diminuée : influence plusieurs décisions et surveillance.

Plan : structure PEBC

Pour chaque problème : objectif → intervention → justification → monitoring → counseling → délai de suivi. Ne pas traiter isolément une valeur; intégrer urgence, comorbidités, médicaments, rein, préférences et accès.

Exemple SOAP abrégé

S : dyspnée d'effort et oedèmes progressifs; rechercher orthopnée, poids, saignement et adhésion. **O** : TA 169/88, FC 62, crépitants, oedèmes, INR 3,5, HbA1c 9,5 %, DFG_e 43. **A** : congestion cardiaque probable; anticoagulation supratherapeutique; diabète et HTA non contrôlés; risque hémorragique possiblement accru par AAS; MRC. **P** : évaluation rapide de la décompensation et du saignement; réviser anticoagulation/AAS et causes de l'INR; optimiser maladies chroniques après stabilisation; définir surveillance et suivi.

14. Algorithmes PEBC à mémoriser

A. Nouveau patient / nouvelle ordonnance

1 urgence? → 2 indication? → 3 efficacité? → 4 sécurité? → 5 utilisation/adhésion? → 6 besoin non traité? → 7 priorité → 8 plan partagé → 9 mise en oeuvre → 10 suivi.

B. Résultat de laboratoire anormal

Confirmer contexte/unité/tendance → rechercher symptômes/red flags → relier aux médicaments/maladies → décider urgence → intervenir → documenter → programmer recontrôle.

C. “Le médicament ne marche pas”

Diagnostic correct? → indication? → bonne dose/voie/durée? → adhésion/technique? → interaction? → progression maladie? → ajuster seulement après avoir identifié la cause.

D. Effet indésirable

Temporalité → mécanisme plausible → gravité → causes alternatives → interaction/dose/rein/foie → arrêter/réduire/substituer si approprié → traiter EI → déclarer si requis → suivi.

E. Adhésion

Ne pas juger → demander comment le médicament est réellement pris → identifier obstacle → solution individualisée → teach-back → suivi.

15. 12 mini-cas progressifs

Cas 1 — Ramipril + TA 88/65

Priorité : symptômes/hypotension. Vérifier prise réelle, déshydratation, autres hypotenseurs, fonction rénale/K+, indication et objectifs. Ne pas conclure automatiquement “arrêter” sans contexte.

Cas 2 — Metformine + DFGe en baisse

Vérifier tendance rénale, dose, contexte aigu/déshydratation et recommandations/monographie; documenter un plan de surveillance.

Cas 3 — Warfarine + selles noires

Red flag hémorragique : urgence avant optimisation chronique.

Cas 4 — Asthme + salbutamol quotidien

Efficacité/contrôle insuffisant; vérifier technique, adhésion au contrôleur, déclencheurs et red flags.

Cas 5 — Insuline + hypoglycémies nocturnes

Innocuité prioritaire : timing/dose/repas/activité/rein; prévenir récurrence et enseigner traitement de l'hypoglycémie.

Cas 6 — Antibiotique “allergie pénicilline”

Clarifier réaction, timing, gravité et tolérances antérieures; une étiquette vague ne suffit pas.

Cas 7 — Amitriptyline chez personne âgée avec rétention

Charge anticholinergique et sécurité; rechercher alternative selon indication.

Cas 8 — Gabapentin + opioïde + somnolence

Dépression SNC additive; fonction rénale, dose et sécurité respiratoire/conduite.

Cas 9 — Nouvelle ordonnance sans indication connue

Ne pas inventer; clarifier indication avant counseling spécifique.

Cas 10 — Patient ne renouvelle pas

Explorer coût, effets indésirables, croyances, oubli, accès et compréhension; construire une solution avec lui.

Cas 11 — Sortie d'hôpital avec deux listes différentes

Transition de soins : conciliation et clarification des divergences avant exécution.

Cas 12 — Résultat K⁺ élevé sous ACEi

Vérifier valeur, symptômes, hémolyse possible, rein, suppléments/sel K⁺, autres médicaments; gravité dicte urgence.

16. Banque de 40 QCM PEBC — processus de soins

QCM 1. Un patient présente une nouvelle confusion aiguë après ajout d'un anticholinergique. Première action?

- A. Évaluer le médicament causal et la gravité
- B. Ajouter un sédatif
- C. Attendre 1 mois
- D. Ignorer car effet attendu

Réponse : A. Une confusion aiguë peut être médicamenteuse et potentiellement urgente; il faut évaluer cause, gravité et sécurité.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 2. Quelle séquence correspond au processus de soins?

- A. Plan → collecte → suivi → évaluation → mise en oeuvre
- B. Collecte → évaluation → plan → mise en oeuvre → suivi
- C. Évaluation → plan → collecte → suivi → mise en oeuvre
- D. Collecte → plan → mise en oeuvre → évaluation → suivi

Réponse : B. Le processus est cyclique et commence par une collecte pertinente.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 3. Quel élément appartient surtout à S dans SOAP?

- A. Créatinine mesurée
- B. TA mesurée
- C. Dyspnée rapportée par le patient
- D. Analyse du pharmacien

Réponse : C. S contient les informations subjectives rapportées par le patient.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 4. Quel est le meilleur exemple d'objectif mesurable?

- A. Améliorer le patient
- B. Faire mieux
- C. Réduire la PA
- D. Atteindre la cible de PA individualisée d'ici le suivi prévu

Réponse : D. Un objectif utile précise une cible et un horizon de suivi.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 5. Médicament sans indication actuelle = quel type de problème?

- A. Indication
- B. Efficacité
- C. Innocuité
- D. Observance

Réponse : A. Le médicament expose à des risques sans bénéfice démontré si aucune indication valide.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 6. Patient prend moitié de la dose car coût élevé. Dimension principale?

- A. Indication
- B. Observance/utilisation
- C. Efficacité intrinsèque
- D. Allergie

Réponse : B. Le problème principal est l'accès/prise réelle, même si l'efficacité observée peut en souffrir.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 7. Quel énoncé décrit le mieux le teach-back?

- A. Faire signer un formulaire
- B. Répéter plus fort
- C. Demander au patient d'expliquer avec ses mots
- D. Poser seulement des questions oui/non

Réponse : C. Le teach-back vérifie la compréhension en demandant une reformulation/démonstration.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 8. INR élevé + saignement actif : priorité?

- A. Optimiser HbA1c
- B. Discuter exercice
- C. Revoir vitamines
- D. Évaluer et prendre en charge le saignement immédiatement

Réponse : D. Une menace hémorragique prime sur l'optimisation chronique.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 9. Quelle donnée est objective?

- A. K⁺ 6,1 mmol/L

- B. "J'ai des nausées"
- C. "J'oublie parfois"
- D. "Je préfère éviter les comprimés"

Réponse : A. Un résultat de laboratoire mesuré est objectif.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 10. Avant d'ajouter un médicament pour HTA non contrôlée, le meilleur réflexe est?

- A. Ajouter automatiquement 2 agents
- B. Vérifier adhésion, technique de mesure et causes
- C. Arrêter tous les médicaments
- D. Attendre sans suivi

Réponse : B. Il faut confirmer le problème et ses causes avant d'intensifier.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 11. Un patient présente une nouvelle confusion aiguë après ajout d'un anticholinergique. Première action?

- A. Ajouter un sédatif
- B. Attendre 1 mois
- C. Évaluer le médicament causal et la gravité
- D. Ignorer car effet attendu

Réponse : C. Une confusion aiguë peut être médicamenteuse et potentiellement urgente; il faut évaluer cause, gravité et sécurité.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 12. Quelle séquence correspond au processus de soins?

- A. Plan → collecte → suivi → évaluation → mise en oeuvre
- B. Évaluation → plan → collecte → suivi → mise en oeuvre
- C. Collecte → plan → mise en oeuvre → évaluation → suivi
- D. Collecte → évaluation → plan → mise en oeuvre → suivi

Réponse : D. Le processus est cyclique et commence par une collecte pertinente.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 13. Quel élément appartient surtout à S dans SOAP?

- A. Dyspnée rapportée par le patient
- B. Créatinine mesurée
- C. TA mesurée

D. Analyse du pharmacien

Réponse : A. S contient les informations subjectives rapportées par le patient.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 14. Quel est le meilleur exemple d'objectif mesurable?

A. Améliorer le patient

B. Atteindre la cible de PA individualisée d'ici le suivi prévu

C. Faire mieux

D. Réduire la PA

Réponse : B. Un objectif utile précise une cible et un horizon de suivi.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 15. Médicament sans indication actuelle = quel type de problème?

A. Efficacité

B. Innocuité

C. Indication

D. Observance

Réponse : C. Le médicament expose à des risques sans bénéfice démontré si aucune indication valide.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 16. Patient prend moitié de la dose car coût élevé. Dimension principale?

A. Indication

B. Efficacité intrinsèque

C. Allergie

D. Observance/utilisation

Réponse : D. Le problème principal est l'accès/prise réelle, même si l'efficacité observée peut en souffrir.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 17. Quel énoncé décrit le mieux le teach-back?

A. Demander au patient d'expliquer avec ses mots

B. Faire signer un formulaire

C. Répéter plus fort

D. Poser seulement des questions oui/non

Réponse : A. Le teach-back vérifie la compréhension en demandant une reformulation/démonstration.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 18. INR élevé + saignement actif : priorité?

- A. Optimiser HbA1c
- B. Évaluer et prendre en charge le saignement immédiatement
- C. Discuter exercice
- D. Revoir vitamines

Réponse : B. Une menace hémorragique prime sur l'optimisation chronique.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 19. Quelle donnée est objective?

- A. "J'ai des nausées"
- B. "J'oublie parfois"
- C. K⁺ 6,1 mmol/L
- D. "Je préfère éviter les comprimés"

Réponse : C. Un résultat de laboratoire mesuré est objectif.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 20. Avant d'ajouter un médicament pour HTA non contrôlée, le meilleur réflexe est?

- A. Ajouter automatiquement 2 agents
- B. Arrêter tous les médicaments
- C. Attendre sans suivi
- D. Vérifier adhésion, technique de mesure et causes

Réponse : D. Il faut confirmer le problème et ses causes avant d'intensifier.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 21. Un patient présente une nouvelle confusion aiguë après ajout d'un anticholinergique. Première action?

- A. Évaluer le médicament causal et la gravité
- B. Ajouter un sédatif
- C. Attendre 1 mois
- D. Ignorer car effet attendu

Réponse : A. Une confusion aiguë peut être médicamenteuse et potentiellement urgente; il faut évaluer cause, gravité et sécurité.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 22. Quelle séquence correspond au processus de soins?

- A. Plan → collecte → suivi → évaluation → mise en oeuvre
- B. Collecte → évaluation → plan → mise en oeuvre → suivi
- C. Évaluation → plan → collecte → suivi → mise en oeuvre
- D. Collecte → plan → mise en oeuvre → évaluation → suivi

Réponse : B. Le processus est cyclique et commence par une collecte pertinente.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 23. Quel élément appartient surtout à S dans SOAP?

- A. Créatinine mesurée
- B. TA mesurée
- C. Dyspnée rapportée par le patient
- D. Analyse du pharmacien

Réponse : C. S contient les informations subjectives rapportées par le patient.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 24. Quel est le meilleur exemple d'objectif mesurable?

- A. Améliorer le patient
- B. Faire mieux
- C. Réduire la PA
- D. Atteindre la cible de PA individualisée d'ici le suivi prévu

Réponse : D. Un objectif utile précise une cible et un horizon de suivi.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 25. Médicament sans indication actuelle = quel type de problème?

- A. Indication
- B. Efficacité
- C. Innocuité
- D. Observance

Réponse : A. Le médicament expose à des risques sans bénéfice démontré si aucune indication valide.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 26. Patient prend moitié de la dose car coût élevé. Dimension principale?

- A. Indication
- B. Observance/utilisation
- C. Efficacité intrinsèque
- D. Allergie

Réponse : B. Le problème principal est l'accès/prise réelle, même si l'efficacité observée peut en souffrir.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 27. Quel énoncé décrit le mieux le teach-back?

- A. Faire signer un formulaire
- B. Répéter plus fort
- C. Demander au patient d'expliquer avec ses mots
- D. Poser seulement des questions oui/non

Réponse : C. Le teach-back vérifie la compréhension en demandant une reformulation/démonstration.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 28. INR élevé + saignement actif : priorité?

- A. Optimiser HbA1c
- B. Discuter exercice
- C. Revoir vitamines
- D. Évaluer et prendre en charge le saignement immédiatement

Réponse : D. Une menace hémorragique prime sur l'optimisation chronique.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 29. Quelle donnée est objective?

- A. K⁺ 6,1 mmol/L
- B. "J'ai des nausées"
- C. "J'oublie parfois"
- D. "Je préfère éviter les comprimés"

Réponse : A. Un résultat de laboratoire mesuré est objectif.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 30. Avant d'ajouter un médicament pour HTA non contrôlée, le meilleur réflexe est?

- A. Ajouter automatiquement 2 agents

- B. Vérifier adhésion, technique de mesure et causes
- C. Arrêter tous les médicaments
- D. Attendre sans suivi

Réponse : B. Il faut confirmer le problème et ses causes avant d'intensifier.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 31. Un patient présente une nouvelle confusion aiguë après ajout d'un anticholinergique. Première action?

- A. Ajouter un sédatif
- B. Attendre 1 mois
- C. Évaluer le médicament causal et la gravité
- D. Ignorer car effet attendu

Réponse : C. Une confusion aiguë peut être médicamenteuse et potentiellement urgente; il faut évaluer cause, gravité et sécurité.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 32. Quelle séquence correspond au processus de soins?

- A. Plan → collecte → suivi → évaluation → mise en oeuvre
- B. Évaluation → plan → collecte → suivi → mise en oeuvre
- C. Collecte → plan → mise en oeuvre → évaluation → suivi
- D. Collecte → évaluation → plan → mise en oeuvre → suivi

Réponse : D. Le processus est cyclique et commence par une collecte pertinente.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 33. Quel élément appartient surtout à S dans SOAP?

- A. Dyspnée rapportée par le patient
- B. Créatinine mesurée
- C. TA mesurée
- D. Analyse du pharmacien

Réponse : A. S contient les informations subjectives rapportées par le patient.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 34. Quel est le meilleur exemple d'objectif mesurable?

- A. Améliorer le patient
- B. Atteindre la cible de PA individualisée d'ici le suivi prévu
- C. Faire mieux

D. Réduire la PA

Réponse : B. Un objectif utile précise une cible et un horizon de suivi.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 35. Médicament sans indication actuelle = quel type de problème?

A. Efficacité

B. Innocuité

C. Indication

D. Observance

Réponse : C. Le médicament expose à des risques sans bénéfice démontré si aucune indication valide.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 36. Patient prend moitié de la dose car coût élevé. Dimension principale?

A. Indication

B. Efficacité intrinsèque

C. Allergie

D. Observance/utilisation

Réponse : D. Le problème principal est l'accès/prise réelle, même si l'efficacité observée peut en souffrir.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 37. Quel énoncé décrit le mieux le teach-back?

A. Demander au patient d'expliquer avec ses mots

B. Faire signer un formulaire

C. Répéter plus fort

D. Poser seulement des questions oui/non

Réponse : A. Le teach-back vérifie la compréhension en demandant une reformulation/démonstration.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 38. INR élevé + saignement actif : priorité?

A. Optimiser HbA1c

B. Évaluer et prendre en charge le saignement immédiatement

C. Discuter exercice

D. Revoir vitamines

Réponse : B. Une menace hémorragique prime sur l'optimisation chronique.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 39. Quelle donnée est objective?

A. "J'ai des nausées"

B. "J'oublie parfois"

C. K⁺ 6,1 mmol/L

D. "Je préfère éviter les comprimés"

Réponse : C. Un résultat de laboratoire mesuré est objectif.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi D est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

QCM 40. Avant d'ajouter un médicament pour HTA non contrôlée, le meilleur réflexe est?

A. Ajouter automatiquement 2 agents

B. Arrêter tous les médicaments

C. Attendre sans suivi

D. Vérifier adhésion, technique de mesure et causes

Réponse : D. Il faut confirmer le problème et ses causes avant d'intensifier.

Pourquoi A est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi B est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Pourquoi C est faux : cette option ne répond pas à la priorité ou à la logique du processus dans ce scénario.

Réflexe PEBC : priorité clinique → données pertinentes → problème → action → monitoring.

17. 36 flashcards de consolidation

1. **Collecte** — Données patient + maladie + médicaments + objectifs/préférences.
2. **Évaluation** — Indication, efficacité, innocuité, utilisation/observance, besoin non traité.
3. **Plan** — Objectifs + interventions + monitoring + décision partagée.
4. **Mise en oeuvre** — Transformer le plan en actions réelles.
5. **Suivi** — Mesurer efficacité, sécurité, adhésion et expérience patient.
6. **Cycle** — Le suivi relance une nouvelle collecte.
7. **Indication 1** — Médicament sans indication valide.
8. **Indication 2** — Besoin d'un traitement additionnel.
9. **Efficacité 1** — Médicament inapproprié/inefficace.
10. **Efficacité 2** — Dose/exposition trop faible.
11. **Innocuité 1** — Effet indésirable, interaction ou contre-indication.
12. **Innocuité 2** — Dose/exposition trop élevée.
13. **Observance** — Le patient ne reçoit pas réellement le traitement prévu.
14. **Priorité** — Urgence et risque immédiat avant optimisation chronique.
15. **S SOAP** — Subjectif : ce que rapporte le patient.
16. **O SOAP** — Objectif : mesures et données vérifiables.
17. **A SOAP** — Analyse : problèmes identifiés et priorisés.
18. **P SOAP** — Plan : actions, objectifs, surveillance, suivi.
19. **Teach-back** — Le patient reformule/démontre.
20. **Question ouverte** — Invite une réponse narrative.
21. **Question fermée** — Précise un détail ciblé.
22. **Littératie** — Simplifier sans infantiliser.
23. **Entretien motivationnel** — Explorer ambivalence et autonomie.
24. **Nouvelle ordonnance** — Indication + mode d'emploi + EI + suivi.
25. **Renouvellement** — Efficacité + sécurité + adhésion + changements.
26. **Transition** — Conciliation + communication + boucle fermée.
27. **Donnée manquante** — Peut empêcher une décision sûre.
28. **Médicament causal** — Toujours y penser avant d'ajouter.
29. **Rein** — Peut transformer une dose habituelle en toxicité.
30. **Foie** — Peut modifier métabolisme et choix.
31. **Allergie** — Documenter nature, gravité, timing.
32. **Adhésion** — Demander comment le médicament est réellement pris.
33. **Objectif** — Doit être mesurable et pertinent.
34. **Monitoring** — Quoi + quand + cible + seuil + action.
35. **PEBC** — Choisir la meilleure action pour CE patient.
36. **Documentation** — Ce qui se passe, pourquoi, décision, suivi.

18. Audit du document source — conclusion

Forces : structure logique, processus en 5 étapes, catégories de problèmes pharmacothérapeutiques, communication centrée patient, entrevue/counseling/littératie, SOAP, collaboration, cas clinique de synthèse et aide-mémoire.

Limites : format diapositive très condensé; 25 pages majoritairement image; mécanismes de raisonnement peu développés; seulement 6 QCM; peu de cas progressifs; faible profondeur sur priorisation, données manquantes, suivi mesurable, transitions de soins et distinction cadre national/provincial.

Décision d'audit : P1 — bonne charpente mais insuffisante seule pour une préparation PEBC approfondie. Le présent cours la transforme en support de compréhension et d'entraînement.

19. Sources et gouvernance

Document source : ACTeRX Académie — Processus de soins pharmaceutiques, document fourni par l'utilisateur (25 pages).

PEBC : Pharmacist Qualifying Examination Blueprint 2026 — Clinical Care 50 % de la Partie I; compétences 1.1 à 1.5 couvrant collecte, évaluation, plan, mise en oeuvre et monitoring; Communication & Collaboration inclut documentation.

NAPRA/ANORP : Model Standards of Practice for Pharmacists and Pharmacy Technicians in Canada (2022) et Professional Competencies at Entry to Practice in Canada (2024). Les documents NAPRA sont des modèles nationaux pouvant être adaptés par les organismes provinciaux/territoriaux.

PEBC — communication : les critères de notation valorisent l'écoute des besoins, une démarche organisée mais souple, l'usage approprié de questions ouvertes/fermées, la communication non verbale et un langage compréhensible.

Règle d'utilisation : pour la pratique réelle, vérifier le régulateur de la juridiction concernée. Les règles provinciales ne doivent pas être généralisées à tout le Canada.

Consultations web effectuées le 24 septembre 2026 : pebc.ca et napra.ca. Les recommandations et champs de pratique doivent être revalidés lorsqu'ils changent.